

AFMCP 4장 — 영양 중심 임상 검진

Part 2 : 피부 검진

강사: Dr. Elizabeth Boham | 한국어 번역본

피부 검진 (Skin Exam) 개요

환자와 악수를 나누는 순간부터 피부 정보 수집이 시작됩니다. 피부 검진 시 온도, 질감, 색깔, 수분 상태, 병변, 모발 분포를 평가합니다.

주요 피부 소견과 영양적 연관성

1. 건조 피부 (Xerosis)

악수할 때 가장 먼저 느낄 수 있는 소견입니다.

- 관련 영양소: 필수 지방산(EFA), 아연, 비타민 A·C·B

2. 모공각화증 (Hyperkeratosis Pilaris)

팔 뒤, 허벅지에서 느껴지는 오돌토돌한 피부.

- 관련 영양소: EFA, 아연, 비타민 A
- 피부 교체(Turnover) 감소로 발생; 아연과 비타민 A 모두 피부 교체에 필수

3. 지루 피부염 (Seborrhea)

홍반 배경의 기름진 노란 비늘. 피지선이 많은 부위(얼굴, 두피, 눈썹, 귀, 코 옆 주름)에 주로 발생.

- 관련 영양소: 비타민 B6, 리보플라빈, B12, 비오틴, 아연, 구리
- 비오틴 결핍이 지루 피부염 발생의 핵심 인자
- 효모 과성장(Yeast Overgrowth)도 원인 가능

4. 여드름 + 손발톱 백점 + 모공각화증 → 아연 부족

세 소견이 함께 나타나면 아연 결핍을 강하게 시사합니다.

- 아연 → 피부 교체 촉진, 비타민 A 활성화에 필요
- 아연 결핍 → 피부 교체 감소 → 여드름 + 모공각화증
- 손발톱 백점(Leukonychia) → 아연 결핍
- 여드름 + 모공각화증만 있으면 → 비타민 A 문제도 병행 고려
- 아연과 비타민 A 함께 보충 → 피부 교체 + 점막 회복

필수 지방산 결핍 (EFA Deficiency) 피부 소견

- 손바닥 건조(Palmar Xerosis), 경도 비후
- 탈모(Alopecia), 모발 손실
- 습진(Eczema), 건조·거친 피부

- 상처 치유 지연(Poor Wound Healing)
- 구강 주위 피부염(Perioral Dermatitis)
- 지단피부염(Acrodermatitis)

EFA 결핍 → 피부 장벽 유지·복구 불가능

- 리놀레산(Linoleic Acid, 오메가-6): 견과류·씨앗·식물성 기름
- 알파-리놀렌산(ALA, 오메가-3): 아마씨·치아씨드·연어·정어리·호두

심한 모낭 각화증 (Phrynoderma)

비타민 A 결핍의 중증 형태. 치료 사례: 비타민 A 100,000 IU를 격일로 10회 근육주사(20일 과정) 후 현저한 피부 개선.

건선 (Psoriasis)

자가면역 질환으로 다음을 고려합니다:

- 환자의 유전적 배경, 장 장벽(Gut Barrier) 상태, 장 투과성 증가 여부
- 자가면역 유발 인자
- 영양적 관점: 비타민 A, EFA, 비타민 D 결핍, 담즙 부족(Bile Insufficiency)
- 담즙 부족과 건선의 연관성 → 담즙산염 보충이 일부 환자에게 효과적
- 염증 유발 식이 제거, 효모 과성장 치료

비타민 C 결핍 피부 소견

역사적으로 16~18세기 선원들이 비타민 C 부족으로 괴혈병(Scurvy)을 앓았습니다. 현재는 경미한 부족 소견이 주로 관찰됩니다.

- 백조 목 모발(Swan Neck Hair): 꼬불꼬불한 모발
- 모낭 자반(Follicular Purpura): 모낭 주변 발적·멍
- 피부 과도 멍(Excessive Bruising)
- 모낭 주변 점상출혈(Perifollicular Petechiae): 비타민 C + 비타민 K 결핍 또는 바이오플라보노이드(케르세틴, 안토시아닌) 부족

※ 와파린 복용자는 비타민 K 섭취량을 일정하게 유지해야 하지만, 비타민 K가 풍부한 음식이 응고를 촉진하는 것은 아닙니다.

장성 지단피부염 (Acrodermatitis Enteropathica)

아연이 세포 내로 이동하지 못하는 희귀 상염색체 열성 유전 질환. 모유 수유 중단 후 1~2주 내 발생.

- 3대 증상: 지단피부염(Acrodermatitis) + 탈모 + 설사
- 바이오마커: 알칼리 인산분해효소(ALP) 감소, 혈청 아연 감소

희귀 질환이지만, 임상에서 피부 발진·설사·낮은 ALP가 함께 나타나면 아연 부족 징후일 수 있습니다.

여드름 (Acne)

영양적 고려사항:

- EFA 부족, 아연 부족, 셀레늄 부족
- 비타민 A·C·E, 비타민 B6, 판토텐산(Pantothenic Acid) 부족
- 고단순당 식이, 염증성 식이
- 유제품(유기농 포함): 호르몬·성장인자 함유 → 일부 환자에서 여드름 자극

여드름 환자의 통합적 평가: 식이 선택, 체성분(허리/엉덩이 비율, 내장지방), Phase Angle(세포 건강 지표)

- Phase Angle 감소 = 세포막 손상(질병·영양실조·기타) → 지중해식 식이 순응도 감소와 연관

결론

피부 검진 요약 슬라이드(단백질 결핍, EFA 결핍, 지용성 비타민·수용성 비타민·식물영양소 관련 소견)를 참고하여 임상에서 활용하시기 바랍니다. 영양사·헬스 코치와의 협력 팀이 피부 개선을 위한 필요한 변화를 이끄는 데 매우 효과적입니다.